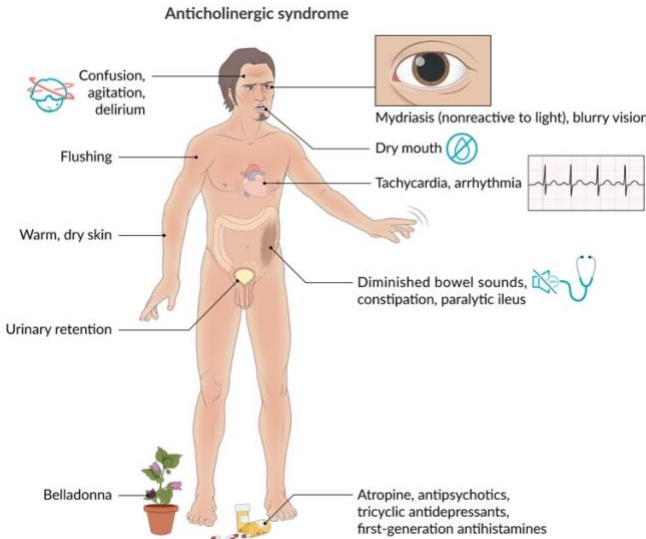


Mydriase

Inhibition de la diaphorèse

Type d'intoxication	Étiologies	Symptômes et signes cliniques	Traitements	Complications	Points importants
Syndrome anticholinergique	Médicaments anticholinergiques : Belladone Atropine, Benztropine, Scopolamine Ipratropium (SAMA) Tiotropium (LAMA) Antihistaminiques Antipsychotiques,	Hyperthermie, confusion, hallucinations, agitation, tachycardie, sécheresse des muqueuses et de la peau, rétention urinaire, diminution des bruits intestinaux	Physostigmine (si absence de contre-indications), refroidissement, sédation avec des benzodiazépines si nécessaire	Arythmies Delirium Convulsions	Surveillance étroite des signes vitaux, éviter les antiémétiques qui aggravent la rétention urinaire et la tachycardie



Absence d'effet sur la diaphorèse

Type d'intoxication	Étiologies	Symptômes et signes cliniques	Traitements	Points importants
Bêta-bloquants	Surdosage médicamenteux	Bradycardie, hypotension, fatigue, confusion, hypoglycémie, bronchospasme (surtout chez les asthmatiques), insuffisance cardiaque	Glucagon, atropine, insuline haute dose/glucose, salin, vasopresseurs (si nécessaire)	Surveiller la glycémie et les signes vitaux, surveillance en soins intensifs nécessaire
Anti-calciqes	Surdosage médicamenteux	Hypotension, bradycardie, vertiges, nausées, insuffisance cardiaque, hyperglycémie	Calcium IV, vasopresseurs, glucagon, insuline haute dose/glucose	Surveillance cardiaque continue, suivi en soins intensifs nécessaire
Digoxine	Surdosage médicamenteux	Nausées, vomissements, diarrhée, confusion, fatigue, vision trouble (vision jaune ou floue), arythmies (bradycardie, extrasystoles)	Anticorps spécifiques anti-digoxine (Digibind), correction des déséquilibres électrolytiques	Éviter les déséquilibres électrolytiques, surveillance cardiaque continue
Tricycliques Anticholinergique et Sérotoninergique	Surdosage médicamenteux	Tachycardie, hypotension, confusion, hallucinations, convulsions, coma, mydriase, hyperréflexie, arythmies, allongement du QRS	Bicarbonate de sodium, benzodiazépines (pour les convulsions), charbon activé (si ingestion récente)	Surveillance cardiaque continue, traitement symptomatique

Type d'intoxication		Étiologies	Symptômes et signes cliniques			Traitements	Complications	Points importants	
Sympathomimétique		Usage récréatif de stimulants (amphétamines, cocaïne), médicaments décongestionnants, certaines drogues de synthèse	Anxiété Mydriase, Diaphorèse, Agitation, Tremblements, Convulsions, Apathie	Hallucinations	Tachycardie, HTA	Hyperthermie, Rhabdomyolyse	Benzodiazépines pour l'agitation et les convulsions, refroidissement externe, contrôle de la pression artérielle avec des antihypertenseurs si nécessaire	Rhabdomyolyse, IRA, ARDS	Surveillance de la température et des signes vitaux, traitement rapide des complications cardiaques et neurologiques
Sevrage Dépresseurs du SNC	Sevrage de benzodiazépines	Arrêt brusque de la consommation après usage prolongé de benzodiazépines (médicaments anxiolytiques et hypnotiques)				Délirium tremens (fièvre, confusion, agitation, hallucinations, instabilité autonome)		Benzodiazépines, réhydratation, correction des électrolytes, surveillance intensive	Délirium
	Sevrage de barbituriques	Arrêt brusque de la consommation après usage prolongé de barbituriques (médicaments sédatifs et hypnotiques)							
	Sevrage d'alcool (éthanol)	Arrêt brusque de la consommation après usage chronique d'alcool							
Syndrome sérotoninergique		Usage combiné ou surdosage d'ISRS, IMAO, amphétamines, triptans, médicaments sérotoninergiques	Triade : 1. Dysfonction autonome (Diaphorèse, Tachycardie, HTA, Mydriase) 2. Excitation neuromusculaire (Hyperréflexie, Myoclonies (+oculaire), Rigidité (MI++) → Hyperthermie 3. État mental altéré (Délirium, Agitation) N/V, Diarrhées			Arrêt des médicaments sérotoninergiques, benzodiazépines pour l'agitation et les convulsions, cyproheptadine (si syndrome sérotoninergique grave)	Rhabdomyolyse, IRA, ARDS, CIVD	Surveiller les interactions médicamenteuses, traitement rapide pour prévenir les complications sévères	

Serotonin syndrome

Definition

- Serotonergic overactivity in patients with exposure to serotonergic drugs

Risk factors

- Concurrent use of multiple serotonergic drugs or combination use with CYP450 inhibitors
- Overdose
- Switching serotonergic drugs without tapering

Serotonergic substances include:

- Antidepressants: e.g., MAOIs, SSRIs
- Recreational stimulants: e.g., MDMA, cocaine
- 5-HT3 receptor antagonists: e.g., ondansetron, granisetron
- Opioids: e.g., tramadol, meperidine

Altered mental status

Anxiety, delirium, psychomotor agitation, seizure, coma

Autonomic dysfunction

Mydriasis

Hyperthermia (due to neuromuscular excitability), diaphoresis

Tachycardia, hypertension, labile blood pressure

Diarrhea, nausea, vomiting

Neuromuscular excitability

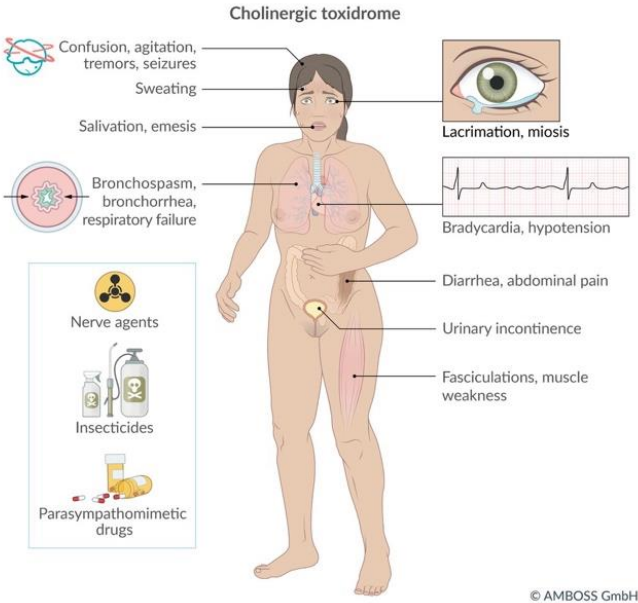
(especially in the lower extremities)

Hyperreflexia, myoclonus, rigidity

Tremor, clonus

Stimulation de la diaphorèse

Type d'intoxication	Étiologies	Symptômes et signes cliniques	Traitements	Points importants
Syndrome cholinergique (Organophosphorés/Carbamates)	Insecticides, agents de guerre chimique, pesticides	Diarrhée, urination, myosis, bronchorrhée, bradycardie, émésis, larmolement, salivation, transpiration excessive, fasciculations musculaires, faiblesse, confusion, convulsions, coma	Atropine, pralidoxime (2-PAM) pour organophosphorés, soins de soutien pour carbamates	Éviter la ré-exposition, traitement rapide nécessaire pour prévenir les complications respiratoires et neurologiques
Syndrome neuroleptique malin	Antipsychotiques (halopéridol, clozapine)	Hyperthermie, rigidité musculaire, dysautonomie (tachycardie, hypertension ou hypotension), altération de l'état mental, transpiration excessive, myosis	Dantrolène, bromocriptine, soins intensifs	Surveillance étroite des signes vitaux, traitement rapide nécessaire pour prévenir les complications sévères
Cyanure	Fumées d'incendie, industries chimiques, ingestion de produits contenant du cyanure	Respiration rapide, dyspnée, convulsions, confusion, coma, hypotension, bradycardie, odeur d'amande amère sur l'haleine, myosis	Hydroxycobalamine, nitrites, thiosulfate de sodium	Traitement urgent requis pour éviter le décès, surveillance intensive des signes vitaux



Inhibition de la diaphorèse

Type d'intoxication	Étiologies	Symptômes et signes cliniques	Traitements	Points importants
Opioides	Usage récréatif, surdose médicamenteuse	Dépression respiratoire, myosis, altération de l'état mental (sommolence, coma), bradycardie, hypothermie, hypotension, constipation	Naloxone, assistance respiratoire (O2)	Surveiller la respiration et l'état mental, administration répétée de naloxone si nécessaire, traitement symptomatique des complications
Dépresseurs du SNC (Anxio./Hypno./Séda.)	Benzodiazépines	Sédation, somnolence, confusion, hypoventilation, hypotension, bradycardie, ataxie, myosis, hypothermie, diminution des réflexes, coma	Flumazénil (avec précaution), soutien ventilatoire et hémodynamique, traitement symptomatique	Précaution avec flumazénil (risque de convulsions), surveillance des signes vitaux, traitement du sevrage si nécessaire
	Alcool (Éthanol)	Sédation, ataxie, dysarthrie, confusion, hypoventilation, hypothermie, vomissements, hypotension, tachycardie, myosis, coma	Soutien ventilatoire et hémodynamique, réhydratation, traitement symptomatique	Surveillance des signes vitaux, prévention du syndrome de sevrage avec benzodiazépines
	Barbituriques	Sédation profonde, confusion, hypoventilation, hypothermie, hypotension, bradycardie, diminution des réflexes, myosis, coma	Soutien ventilatoire et hémodynamique, charbon activé (si ingestion récente), hémodialyse (si sévère)	Surveillance en soins intensifs, prévention du syndrome de sevrage, traitement symptomatique des complications

Intoxications n'affectant pas la dilatation des pupilles

Stimulation de la diaphorèse

Type d'intoxication	Étiologies	Symptômes et signes cliniques	Traitements	Points importants
Salicylates	Surdosage médicamenteux	Acouphènes, hyperventilation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, confusion, transpiration excessive, fièvre, vertiges, acidose métabolique, alcalose respiratoire, coma, convulsions	Charbon activé, bicarbonate de sodium, hémodialyse	Surveiller le pH sanguin et les électrolytes, traitement rapide nécessaire

Absence d'effet sur la diaphorèse

Type d'intoxication	Étiologies	Symptômes et signes cliniques	Traitements	Points importants
Paracétamol	Surdosage accidentel ou volontaire	Nausées, vomissements, douleurs abdominales, hépatotoxicité, insuffisance hépatique (ictère, encéphalopathie hépatique), insuffisance rénale dans les cas graves	N-acétylcystéine (NAC), charbon activé (si ingestion récente)	Surveiller les enzymes hépatiques, traitement précoce avec N-acétylcystéine indispensable
Monoxyde de carbone (CO)	Inhalation de fumée, mauvaise combustion	Céphalées, vertiges, nausées, vomissements, dyspnée, confusion, syncope, coma, convulsions, peau rouge cerise, myalgies, douleur thoracique	Oxygénothérapie hyperbare, oxygène à haute concentration	Mesurer la carboxyhémoglobine, traitement rapide nécessaire pour éviter des séquelles neurologiques
Lithium	Surdosage médicamenteux	Tremblements, nausées, vomissements, diarrhée, confusion, somnolence, polyurie, déshydratation, ataxie, hyperréflexie, convulsions, coma	Arrêt du lithium, réhydratation, hémodialyse	Surveiller les niveaux sériques de lithium, traitement symptomatique des complications neurologiques
Mercure	Exposition industrielle, ingestion de poissons contaminés	Tremblements, gingivostomatite, troubles neuropsychiatriques (irritabilité, insomnie, perte de mémoire), insuffisance rénale, diarrhée, dermatite	Chélateurs (dimercaprol, succimer)	Surveillance continue des niveaux sanguins de mercure, traitement prolongé
Plomb	Exposition industrielle, peinture au plomb	Anémie, douleurs abdominales, constipation, neuropathie périphérique, faiblesse musculaire, troubles cognitifs (irritabilité, troubles de la mémoire), saturnisme (ligne bleue sur les gencives)	Chélateurs (EDTA, dimercaprol, succimer)	Surveillance des niveaux de plomb sanguins, traitement prolongé
Fer	Ingestion accidentelle (souvent chez les enfants)	Vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, hépatotoxicité, choc hypovolémique, tachypnée, léthargie, coma, convulsions, hypoglycémie	Défériprone, déférasirox, dexrazoxane	Radiographie abdominale pour visualiser les comprimés, traitement rapide nécessaire
Arsenic	Pesticides, eaux contaminées, industries	Douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, neuropathie périphérique, hyperpigmentation, kératose palmoplantaire, confusion, fatigue, insuffisance rénale	Chélateurs (dimercaprol, succimer)	Analyse urinaire pour détecter l'arsenic, traitement prolongé nécessaire
Méthanol	Solvants, produits de nettoyage, ingestion accidentelle ou volontaire	Altération de l'état mental, céphalées, vertiges, vision floue, douleurs abdominales, nausées, vomissements, dyspnée, acidose métabolique, coma, convulsions	Fomépizole, éthanol, bicarbonate de sodium, hémodialyse	Surveillance des niveaux sériques de méthanol et de l'acidose, traitement rapide indispensable
Éthylène glycol	Antigel, ingestion accidentelle ou volontaire	Symptômes d'ivresse, nausées, vomissements, douleurs abdominales, dyspnée, confusion, convulsions, insuffisance rénale, hypocalcémie, acidose métabolique	Fomépizole, éthanol, bicarbonate de sodium, hémodialyse	Surveillance des niveaux sériques d'éthylène glycol et de l'acidose, traitement rapide indispensable
Isopropyle alcool	Solvants, produits de nettoyage, ingestion accidentelle ou volontaire	Altération de l'état mental, céphalées, vertiges, hypotension, hypothermie, douleurs abdominales, nausées, vomissements, dyspnée, confusion, coma, hypoglycémie	Traitement symptomatique, hémodialyse si sévère	Surveillance de l'état neurologique et hémodynamique, traitement symptomatique des complications
Produits caustiques	Ingestion de produits de nettoyage industriels ou domestiques (acides ou bases fortes)	Douleurs buccales et abdominales, dysphagie, vomissements, hypersalivation, ulcères oraux, nécrose œsophagienne ou gastrique, perforation gastro-intestinale	Dilution précoce avec de l'eau ou du lait, endoscopie précoce	Risque de perforation gastro-intestinale, éviter le charbon activé, traitement rapide indispensable
Hydrocarbures	Inhalation ou ingestion d'hydrocarbures (essence, kérosène, diluants de peinture)	Toux, dyspnée, vomissements, confusion, léthargie, pneumonie chimique (fièvre, tachypnée, râles crépitants), tachycardie, hypoxie	Oxygénothérapie, traitement symptomatique, éviter les vomissements	Risque élevé de pneumonie d'aspiration, surveillance respiratoire nécessaire, traitement symptomatique
Antivitamine K (Warfarine)	Surdosage médicamenteux	Hémorragies (gingivales, nasales, digestives, intracrâniennes), ecchymoses, hématurie, méléna, hémarthrose, anémie	Vitamine K, plasma frais congelé, concentrés de complexe prothrombique (CCP)	Surveillance de l'INR, ajustement de la dose de vitamine K
Héparine	Surdosage médicamenteux	Hémorragies (gingivales, nasales, digestives), ecchymoses, thrombocytopénie, hématurie, hématome, méléna, épistaxis, anémie	Protamine sulfate	Suivi des plaquettes et des signes de saignement, ajustement de la dose de protamine
Syndrome extrapyramidal	Antipsychotiques : Haldopéridol Anticonvulsivants : Carbamazépine Antidépresseurs Antiémetiques : Métoclopramide	- Dystonie aiguë : spasmes musculaires douloureux, grimaces faciales, torticolis, protrusion ou torsion de la langue, crise oculogyre (déviation spasmodique vers le haut des yeux) - Pseudoparkinsonisme : rigidité, démarche raide, tremblements, bradykinésie - Akathisie : agitation, incapacité à rester assis ou debout - Dyskinésie tardive : mouvements involontaires	- Dystonie aiguë : anticholinergiques (benztropine), antihistaminiques (diphenhydramine), benzodiazépines - Pseudoparkinsonisme : anticholinergiques (benztropine), agonistes dopaminergiques (amantadine)	Inclut dystonie aiguë, akathisie, parkinsonisme, et dyskinésie tardive.

			- Akathisie : bêta-bloquants (propranolol), benzodiazépines - Dyskinésie tardive : inhibiteurs de la VMAT (valbenazine, deutetrabenazine)	
--	--	--	---	--

Syndrome extrapyramidal : Une collection de troubles moteurs résultant de l'inhibition des voies dopaminergiques dans les ganglions de la base.

Crise oculogyre :

- Définition** : un épisode de mouvement spasmodique vers le haut des yeux qui dure généralement plusieurs minutes.
- Étiologie** : induite par des médicaments (neuroleptiques, amantadine, benzodiazépines), usage d'alcool, fatigue, stress émotionnel, troubles des ganglions de la base (par exemple, parkinsonisme post-encéphalitique, maladie de Parkinson).
- Caractéristiques cliniques** : regard fixe suivi d'une déviation vers le haut des yeux, agitation, douleur oculaire.
- Traitement** : benztropine et/ou diphenhydramine.